CABOMETYX® (cabozantinib) comprimés 60 mg | 40 mg | 20 mg

IPSEN

CABOMETYX® (cabozantinib) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de tumeurs neuroendocrines extra-pancréatiques (TNEep) et pancréatiques (TNEp) bien différenciées, non résécables ou métastatiques, qui ont progressé après au moins un traitement systémique antérieur autre que les analogues de la somatostatine. [1]

Indication non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 23/01/2026.
Liste I.
Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

CABOMETYX® : ITK INHIBANT VEGFR, MET & AXL [1]

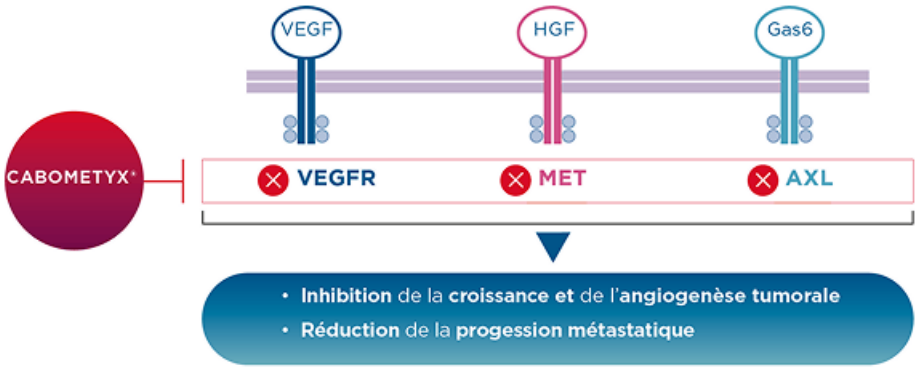

Illustration adaptée d'après [1]

CABOMETYX® est une petite molécule inhibitrice de plusieurs récepteurs à activité tyrosine kinase, incluant **VEGFR**, **MET**, et **AXL** qui sont impliqués dans [1] :

- la croissance et l'angiogenèse tumorale ;
- la résistance aux médicaments ;
- la progression métastatique du cancer.

Dans un large éventail de modèles précliniques de tumeurs, **CABOMETYX®** a été associé à [1] :

- une **inhibition dose-dépendante de la croissance tumorale** ;
- une **régression tumorale** ;
- et/ou une **inhibition de la formation de métastases**.

VEGFR : récepteur « vascular endothelial growth factor » pour facteur de croissance vasculaire endothélial ; **MET** : récepteur du facteur de croissance hépatocytaire de nature protéique;

AXL : anexelekto ; **ITK** : inhibiteur de la tyrosine kinase.

ÉTUDE CABINET : UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE AVEC CABOMETYX® VS PLACEBO DANS LE TRAITEMENT DES TUMEURS NEUROENDOCRINES NON RÉSÉCABLES OU MÉTASTATIQUES [2]

CABINET est une étude de phase III, américaine, multicentrique (62 centres), randomisée (2:1), en double aveugle, contrôlée vs placebo, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance de CABOMETYX® vs placebo chez des patients adultes atteints de tumeurs neuroendocrines extra-pancréatiques (TNEep) ou pancréatiques (TNEp) bien différenciées, localement avancées ou métastatiques, ayant progressé après au moins un traitement antérieur autre que les analogues de la somatostatine. Deux cohortes indépendantes étaient menées en parallèle. Le critère principal d'évaluation était la survie sans progression. [1,2]

Pour plus d'informations sur la méthodologie de l'étude CABINET, les critères de sélection et les caractéristiques des patients à l'inclusion, cliquez-ici

CRITÈRE PRINCIPAL : SURVIE SANS PROGRESSION (SSP) [2]

Évaluation radiologique par un comité indépendant en aveugle selon RECIST 1.1 - Médiane estimée selon la méthode de Kaplan-Meier.

Cohorte TNEep

Une SSP médiane de 8,4 mois avec CABOMETYX® *vs* 3,9 mois avec le placebo [1,2]

Cohorte TNEp

Une SSP médiane de 13,8 mois avec CABOMETYX® *vs* 4,4 mois avec le placebo [1,2]

Suivi médian

23 MOIS

Analyse **PRINCIPALE**[1,2] — *Date de cut-off : 24 août 2023*

Cohorte TNEep		Cohorte TNEp	
8,4 mois IC 95% [7,6 - 12,7]	**3,9** mois IC 95% [3,0 - 5,7]	**13,8** mois IC 95% [9,2 - 18,5]	**4,4** mois IC 95% [3,0 - 5,9]
HR **0,38***		HR **0,23***	
IC 95% [0,25 - 0,59]		IC 95% [0,12 - 0,42]	

CABOMETYX® (n=134) Placebo (n=69) — CABOMETYX® (n=64) Placebo (n=31)

**Estimé à l'aide du modèle des risques proportionnels de Cox. L'étude CABINET a été interrompue pour des raisons d'efficacité au moment d'une analyse intermédiaire prévue uniquement à des fins de futilité. L'erreur de type I n'a pas été formellement contrôlée et les*

valeurs p ne sont pas présentées. L'intervalle de confiance à 95 % présenté est descriptif et ne signifie pas que la significativité statistique a été atteinte.

SSP : survie sans progression ; **RECIST** : « response evaluation criteria in solid tumors » pour critères d'évaluation de la réponse dans les tumeurs solides ; **IC** : intervalle de confiance ; **HR** : « hazard ratio ».

TOLÉRANCE DE L'ÉTUDE [2]

Cohorte TNEep

Durée médiane de traitement : mois [intervalle]

CABOMETYX® (n = 132)	**5,5 mois** [0,2-32,4]
Placebo (n = 67)	**2,8 mois** [0,6-21,4]

Incidence des événements indésirables (EI)

	CABOMETYX® (n=132)	Placebo (n=67)
Au moins 1 EI (tous grades), n (%)	**130** (98)	**55** (82)
Au moins 1 EI de grade 3 ou plus, n (%)	**82** (62)	**18** (27)
EI ayant conduit à une interruption du traitement, n (%)	**34** (31)	**9** (15)
EI ayant conduit à une réduction de la dose administrée n (%)	**87** (66)	**7** (10)

- Les **événements indésirables de grade 3 ou 4 les plus fréquents étaient :** hypertension (21%), fatigue (13%) et diarrhée (11%)
- **4 événements de grade 5 ont été identifiés comme possiblement lié au traitement,** parmi lesquels un cas d'hémorragie gastrique, un cas d'arrêt cardiaque.

Evénements indésirables les plus fréquents

Effets indésirables les plus fréquents (avec une incidence ≥ 20 % pour les EI tous grades confondus et ≥ 10 % pour les EI de grade ≥ 3 dans le bras CABOMETYX®) : fatigue, diarrhée, ↑ ASAT, ↑ ALAT, hypertension, thrombocytopénie, nausée, mucite buccale, syndrome d'erythrodysesthésie palmo-plantaire (SEPP), anorexie, dysgueusie, neutropénie, leucopénie, anémie, lymphopénie, hypothyroïdisme, éruption maculopapuleuse, perte de poids.

Cohorte TNEp

Durée médiane de traitement : mois [intervalle]

CABOMETYX® (n = 63)	**8,3 mois** [0,5-39,6]
Placebo (n = 31)	**2,9 mois** [0,5-11,2]

Incidence des événements indésirables (EI)

	CABOMETYX® (n=63)	Placebo (n=31)
Au moins 1 EI (tous grades), n (%)	**62** (98)	**26** (84)
Au moins 1 EI de grade 3 ou plus, n (%)	**41** (65)	**7** (23)
EI ayant conduit à une interruption du traitement, n (%)	**10** (20)	**0** (0)
EI ayant conduit à une réduction de la dose administrée, n (%)	**43** (68)	**6** (19)

- Les **événements indésirables de grade 3 ou 4 les plus fréquents étaient :** hypertension (22%), fatigue (11%) et événement thromboembolique (11%)
- **Aucun événement de grade 5 n'a été notifié.**

Evénements indésirables les plus fréquents

Effets indésirables les plus fréquents (avec une incidence ≥ 20 % pour les EI tous grades confondus et ≥ 10 % pour les EI de grade ≥ 3 dans le bras CABOMETYX®) : fatigue, diarrhée, ↑ ASAT, ↑ ALAT, hypertension, thrombocytopénie, nausée, mucite buccale, syndrome d'erythrodysesthésie palmo-plantaire (SEPP), anorexie, dysgueusie, neutropénie, ↑ PAL, vomissements, hypophosphatémie, événement thromboembolique.

EI : événements indésirables ; **ASAT** : Aspartate aminotransférase ; **ALAT** : Alanine aminotransférase ; **SEPP** : Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire ; **PAL** : Phosphatase alcaline ; **GGT** : Gamma-glutamyl transférase.

DONNÉES DE SÉCURITÉ [1]

Résumé du profil de tolérance [1]

Dans la population atteinte de TNE, les effets indésirables graves les plus fréquents (≥ 1%) sont : hypertension, fatigue, embolie pulmonaire, vomissement, diarrhée, nausée, embolie.

Effets indésirables les plus fréquents tous grades et toutes populations confondus (≥ 25 %) : diarrhée, fatigue, nausée, appétit diminué, syndrome d'erythrodysesthésie palmo-plantaire (SEPP), hypertension.

Effets indésirables peu fréquents (≥ 1/1000 à < 1/100) : convulsion, accident cérébrovasculaire, syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, infarctus du myocarde aigu, crise aiguë d'hypertension, thrombose artérielle, embolie artérielle, pneumothorax, glossodynie, hépatite cholestatique, ostéonécrose de la mâchoire, complications de plaie.

Effets indésirables avec une fréquence indéterminée (ne peut être estimée à partir des données disponibles) : anévrismes et dissections artérielles, vasculite cutanée.

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur https://signalement.social-sante.gouv.fr

Effets indésirables [1]

Très fréquents (≥ 1/10) et fréquents (de ≥ 1/100 à < 1/10) rapportés au cours des études cliniques ou lors de la commercialisation chez les patients traités par CABOMETYX® en monothérapie. [1]

CLASSE DE SYSTÈME-ORGANE MedDRA	TRÈS FRÉQUENT (≥ 1/10)	FRÉQUENT (de ≥ 1/100 à < 1/10)
Infections et infestations		abcès, pneumonie
Affections hématologiques et du système lymphatique	anémie, thrombocytopénie	neutropénie, lymphopénie
Affections endocriniennes	hypothyroïdie	
Troubles du métabolisme et de la nutrition	appétit diminué, hypomagnésémie, hypokaliémie, hypoalbuminémie, hypocalcémie	déshydratation, hypophosphatémie, hyponatrémie, hyperkaliémie, hyperbilirubinémie, hyperglycémie, hypoglycémie
Affections du système nerveux	dysgueusie, céphalées, sensation vertigineuse	neuropathie périphérique
Affections de l'oreille et du labyrinthe		acouphène
Affections vasculaires	hypertension, hémorragie	thrombose veineuse, hypotension, embolie
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	dysphonie, dyspnée, toux	embolie pulmonaire, rhinite allergique
Affections gastro-intestinales	diarrhée, nausées, vomissements, stomatite, constipation, douleurs abdominales, dyspepsie	perforation gastro-intestinale*, pancréatite, fistule, maladie de reflux gastro-œsophagien, hémorroïdes, douleur buccale, bouche sèche, dysphagie, flatulence
Affections hépatobiliaires		encéphalopathie hépatique
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	érythrodysesthésie palmo-plantaire, éruption cutanée**	prurit, alopécie, sécheresse cutanée, couleur des cheveux modifiée, hyperkératose, érythème
Affections musculo-squelettiques et systémiques	douleurs des extrémités, arthralgie	spasmes musculaires
Affections du rein et des voies urinaires		protéinurie
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	fatigue, inflammation muqueuse, asthénie, oedème périphérique	
Investigations	poids diminué, ALAT sériques augmentées, ASAT augmentées, phosphatase alcaline sanguine augmentée	GGT augmentée, créatinine sanguine augmentée, amylase augmentée, lipase augmentée, cholestérol sanguin augmenté, triglycérides sanguins augmentés, globules blancs diminués

*Des cas mortels ont été rapportés.
**Eruption cutanée est un terme composite qui inclut : dermatite, dermatite acnéiforme, dermite bulleuse, éruption cutanée avec exfoliation, éruption cutanée érythémateuse, éruption cutanée folliculaire, éruption cutanée maculaire, éruption cutanée maculo-papuleuse, éruption cutanée papuleuse, éruption cutanée prurigineuse et éruption d'origine médicamenteuse.

CONTRE-INDICATIONS [1]

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONDUITE À TENIR [1]

Comme la plupart des effets indésirables surviennent au début du traitement, le médecin doit surveiller le patient de façon rapprochée pendant les 8 premières semaines de traitement afin de déterminer si une adaptation de la dose est nécessaire. Les effets indésirables qui généralement surviennent précocement sont : hypocalcémie, hypokaliémie, thrombopénie, hypertension, syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire, protéinurie et effets gastro-intestinaux (douleur abdominale, inflammation des muqueuses, constipation, diarrhée et vomissements). La prise en charge des effets indésirables suspectés peut nécessiter une réduction de la posologie ou une interruption temporaire du traitement par CABOMETYX®. Des réductions de la posologie et des interruptions de traitement en raison d'un événement indésirable sont survenues chez 46 à 67 % et 70 à 84 %, respectivement, des patients traités par CABOMETYX® dans les essais cliniques pivots en monothérapie (dont l'essai CABINET dans les TNE). Deux réductions de la posologie ont été nécessaires chez 9,4 % à 33 % des patients. Le délai médian jusqu'à la première réduction de la posologie était de 38 à 106 jours et le délai jusqu'à la première interruption de traitement était de 28 à 68 jours.

Hépatotoxicité : Des anomalies des tests de la fonction hépatique (augmentation de l'ALAT, de l'ASAT et de la bilirubine) ont été fréquemment observées chez les patients traités par CABOMETYX®. Il est recommandé de pratiquer des tests de la fonction hépatique (ALAT, ASAT et bilirubine) avant l'initiation du traitement par CABOMETYX® et d'effectuer une surveillance attentive au cours du traitement. Chez les patients présentant une détérioration de la fonction hépatique considérée comme liée au traitement par CABOMETYX® (c'est-à-dire lorsqu'aucune autre cause n'est identifiée), il convient de suivre les recommandations d'adaptation de posologie (voir rubrique Posologie et mode d'administration du RCP). De rares cas de syndrome de raréfaction des voies biliaires ont été rapportés. Tous les cas sont survenus chez des patients ayant reçu des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, avant ou en même temps que le traitement par CABOMETYX®. CABOMETYX® est éliminé principalement par voie hépatique. Une surveillance accrue de la tolérance générale est recommandée chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou modérée. Une proportion relative plus élevée de patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B) a développé une encéphalopathie hépatique au cours du traitement par CABOMETYX®. CABOMETYX® n'est pas recommandé en cas d'insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C).
Perforations et fistules : Des cas graves de perforations gastro-intestinales (GI) et de fistules, parfois d'issue fatale, ont été observées avec CABOMETYX®. Les patients qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin (par exemple maladie de Crohn, colite ulcéreuse, péritonite, diverticulite ou appendicite), d'une infiltration tumorale du tractus digestif, ou qui présentent des complications d'une chirurgie digestive antérieure (en particulier quand elle est associée à une cicatrisation tardive ou incomplète), doivent être attentivement évalués avant le début d'un traitement par CABOMETYX® par la suite, ces patients doivent être surveillés de façon rapprochée afin de détecter les symptômes éventuels de perforations et de fistules, y compris d'abcès et de septicémie. Une diarrhée persistante ou récurrente pendant le traitement peut être un facteur de risque de fistule anale. Le traitement par CABOMETYX® doit être interrompu chez les patients présentant une perforation GI ou une fistule qui ne peut être prise en charge de façon appropriée.
Troubles gastro-intestinaux (GI) : La diarrhée, les nausées/vomissements, la diminution de l'appétit et la stomatite /douleur buccale figurent parmi les effets indésirables GI les plus fréquemment rapportés (voir rubrique Effets indésirables du RCP). Une prise en charge médicale précoce, comprenant des soins de support par antiémétiques, antidiarrhéiques ou antiacides, doit être instaurée pour éviter la déshydratation, les déséquilibres électrolytiques et la perte de poids. L'interruption ou la réduction de la dose, ou l'arrêt définitif de CABOMETYX®, doivent être envisagés en cas d'effets indésirables GI significatifs persistants ou récurrents.
Événements thromboemboliques : Des événements thromboemboliques veineux, dont des embolies pulmonaires, et des événements thromboemboliques artériels, parfois fatals, ont été observés avec CABOMETYX®. CABOMETYX® doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant un risque ou ayant des antécédents d'événements thromboemboliques. Le traitement par CABOMETYX® doit être arrêté chez les patients qui développent un infarctus aigu du myocarde ou toute autre complication thromboembolique cliniquement significative. Dans l'étude CABINET, la fréquence des événements thromboemboliques veineux était plus élevée dans la cohorte TNEp (19 %) que dans la cohorte TNEep (3,8 %) chez les patients ayant reçu CABOMETYX®.
Hémorragies : Des hémorragies sévères, parfois fatales, ont été observées avec CABOMETYX®. Les patients ayant des antécédents de saignements sévères doivent faire l'objet d'une évaluation minutieuse avant d'initier un traitement par CABOMETYX®. CABOMETYX® ne doit pas être administré aux patients qui présentent ou sont à risque de présenter une hémorragie sévère.
Anévrismes et dissections artérielles : L'utilisation d'inhibiteurs des voies du VEGF chez les patients souffrants ou non d'hypertension peut favoriser la formation d'anévrismes et/ou de dissections artérielles. Avant l'instauration de CABOMETYX®, ce risque doit être soigneusement pris en considération chez les patients présentant des facteurs de risque tels que l'hypertension ou des antécédents d'anévrisme.
Thrombopénie : Au cours de l'étude CABINET dans les TNE notamment, des cas de thrombopénie et de diminution des plaquettes ont été rapportés avec CABOMETYX®. Le taux de plaquettes doit être surveillé au cours du traitement par CABOMETYX® et la dose doit être modifiée en fonction de la sévérité de la thrombopénie.
Complications de la cicatrisation des plaies : Des cas de complications de la cicatrisation des plaies ont été observés avec CABOMETYX®. Dans la mesure du possible, le traitement par CABOMETYX® doit être arrêté au moins 28 jours avant une opération chirurgicale programmée, y compris une chirurgie dentaire ou des soins dentaires invasifs. Après l'intervention chirurgicale, la décision de reprendre le traitement par CABOMETYX® doit être fondée sur l'observation d'une cicatrisation adéquate selon le jugement du clinicien. CABOMETYX® doit être arrêté chez les patients qui présentent des complications de la cicatrisation nécessitant une intervention médicale.

Hypertension : Des cas d'hypertension, incluant une crise aiguë d'hypertension, ont été observés avec CABOMETYX®. La tension artérielle doit être correctement contrôlée avant l'instauration du traitement par CABOMETYX®. Après l'initiation de CABOMETYX®, la tension artérielle doit être surveillée précocement et régulièrement, et traitée si nécessaire par un traitement antihypertenseur approprié. Si l'hypertension persiste malgré le traitement antihypertenseur, le traitement par CABOMETYX® doit être arrêté jusqu'à ce que la pression artérielle soit contrôlée, après quoi le traitement par CABOMETYX® peut être repris à une dose réduite. CABOMETYX® doit être arrêté en cas d'hypertension sévère et persistante, malgré le traitement antihypertensif et la réduction de la dose de CABOMETYX®. En cas de crise hypertensive avérée, le traitement par CABOMETYX® doit être arrêté.
Ostéonécrose : Des cas d'ostéonécrose de la mâchoire (ONM) ont été observés avec CABOMETYX®. Un examen de la cavité buccale doit être effectué avant l'initiation de CABOMETYX® et régulièrement pendant le traitement par CABOMETYX®. La pratique des règles d'hygiène bucco-dentaire doit être recommandée aux patients. Dans la mesure du possible, le traitement par CABOMETYX® doit être suspendu au moins 28 jours avant une chirurgie dentaire programmée ou des soins dentaires invasifs. La prudence s'impose chez les patients recevant des produits associés à des ONM, tels que les bisphosphonates. Le traitement par CABOMETYX® doit être interrompu chez les patients qui développent une ONM.
Syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire (SEPP) : Des cas de syndrome d'érythrodysesthésie palmoplantaire (SEPP ou syndrome main-pied) ont été observés avec CABOMETYX®. Dans les cas de SEPP sévères, il faut envisager l'arrêt du traitement par CABOMETYX®. Le traitement par CABOMETYX® pourra être repris à une dose plus faible après résolution du SEPP à un grade 1.
Protéinurie : Des cas de protéinurie ont été observés avec CABOMETYX®. Le taux de protéines dans les urines doit être surveillé régulièrement pendant le traitement par CABOMETYX®. Le traitement par CABOMETYX® doit être arrêté chez les patients qui développent un syndrome néphrotique.
Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) : Des cas de SEPR ont été observés avec CABOMETYX®. Ce syndrome doit être envisagé chez tout patient présentant des symptômes tels que des convulsions, des maux de tête, des troubles visuels, une confusion ou une altération des fonctions mentales. Le traitement par CABOMETYX® doit être arrêté chez les patients qui présentent un SEPR.
Prolongation de l'intervalle QT : CABOMETYX® doit être utilisé avec précaution chez les patients ayant un antécédent d'allongement de l'intervalle QT, chez les patients prenant des traitements antiarythmiques ou chez les patients ayant des maladies cardiaques préexistantes, une bradycardie ou une anomalie électrolytique. Pendant le traitement par CABOMETYX®, une surveillance régulière de l'ECG et des électrolytes (calcémie, kaliémie et magnésémie) doit être envisagée.
Dysfonctionnement thyroïdien : Une exploration biologique de la fonction thyroïdienne est recommandée chez tous les patients avant l'initiation du traitement. Les patients avec une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie préexistante doivent être traités conformément à la pratique médicale courante avant le début du traitement par CABOMETYX®. Pendant le traitement par CABOMETYX®, tous les patients doivent être étroitement surveillés afin de détecter tout signe et symptôme de dysfonctionnement thyroïdien. La fonction thyroïdienne doit être surveillée régulièrement tout au long du traitement par CABOMETYX®. Les patients qui développent un dysfonctionnement thyroïdien doivent être traités conformément à la pratique médicale courante.
Anomalies biologiques : CABOMETYX® a été associé à une incidence accrue d'anomalies électrolytiques (incluant hypo- et hyperkaliémie, hypomagnésémie, hypocalcémie, hyponatrémie). Il est recommandé de surveiller les paramètres biochimiques au cours du traitement par CABOMETYX® et d'instaurer, si nécessaire, un traitement correctif approprié selon les référentiels de pratique clinique. L'interruption du traitement ou la réduction de la dose, ou l'arrêt définitif de CABOMETYX®, doivent être envisagés en cas d'anomalies significatives, persistantes ou récurrentes.
Inducteurs et inhibiteurs du CYP3A4 : CABOMETYX® est un substrat du CYP3A4. L'administration concomitante de CABOMETYX® et de kétoconazole, un puissant inhibiteur du CYP3A4, a entrainé une augmentation de la concentration plasmatique de CABOMETYX®. La prudence est requise lorsque CABOMETYX® est administré avec de puissants inhibiteurs du CYP3A4. L'administration concomitante de CABOMETYX® et de rifampicine, un puissant inducteur du CYP3A4, a entrainé une diminution de la concentration plasmatique de CABOMETYX®. Il faut donc éviter l'administration prolongée de puissants inducteurs du CYP3A4 avec CABOMETYX®.
Substrats de la P-glycoprotéine : CABOMETYX® est un inhibiteur de la P-gp. Il est donc possible que CABOMETYX® puisse augmenter les concentrations plasmatiques des substrats de la P-gp co-administrés. Il convient donc de mettre en garde les patients quant à la prise de substrats de la P-gp (par ex., fexofénadine, aliskiren, ambrisentan, dabigatran étexilate, digoxine, colchicine, maraviroc, posaconazole, ranolazine, saxagliptine, sitagliptine, talinolol, tolvaptan) pendant leur traitement par CABOMETYX®.

Inhibiteurs de la MRP2 : L'administration d'inhibiteurs de la MRP2 peut entrainer des augmentations des concentrations plasmatiques de CABOMETYX®. La prudence est requise lors de l'utilisation concomitante d'inhibiteurs de la MRP2 (par ex. ciclosporine, éfavirenz, emtricitabine).
Excipients : Lactose (excipient à effet notoire) : Les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares) ne doivent pas prendre ce médicament.
Sodium : Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-a-d. qu'il est essentiellement "sans sodium".

MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONDUITE À TENIR [1]

Femmes en capacité de procréer/Contraception chez les hommes et les femmes : Il convient de conseiller aux femmes en capacité de procréer d'éviter toute grossesse pendant le traitement sous CABOMETYX®. Les partenaires de sexe féminin de patients de sexe masculin traités par CABOMETYX® doivent également éviter de tomber enceintes. Des méthodes de contraception efficaces doivent être utilisées par les patients de sexes masculin et féminin et par leurs partenaires pendant toute la durée du traitement et pendant au moins 4 mois après la fin du traitement. Sachant que les contraceptifs oraux ne peuvent pas être considérés comme des « méthodes efficaces de contraception », ils doivent être utilisés avec une autre méthode, telle qu'une méthode de contraception mécanique.
Grossesse : Aucune étude n'a été réalisée sur des femmes enceintes traitées par CABOMETYX®. Des études sur des animaux ont mis en évidence des effets embryo-foetaux et tératogènes. On ne connait pas le risque potentiel pour l'homme. CABOMETYX® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, à moins que la situation clinique de la femme ne justifie le traitement avec ce composé.
Allaitement : On ne sait pas si CABOMETYX® et/ou ses métabolites sont excrétés dans le lait maternel. Compte tenu du danger potentiel pour le nourrisson, les patientes doivent arrêter d'allaiter pendant le traitement par CABOMETYX®, et pendant au moins 4 mois après la fin du traitement.
Fertilité : On ne dispose d'aucune donnée sur la fertilité humaine. Il est recommandé aux hommes et aux femmes en âge de procréer de prendre conseil afin d'envisager des stratégies de préservation de la fertilité avant de démarrer le traitement.

ASAT : Aspartate aminotransférase ; **ALAT** : Alanine aminotransférase ; **GGT** : Gamma-glutamyl transférase.

Pour une information complète, se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit CABOMETYX®

CABOMETYX® pour le traitement des tumeurs neuroendocrines non résécables ou métastatiques

Indication non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 23/01/2026.

Liste I. Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en cliquant ici

---

Bibliographie

1. Résumé des Caractéristiques du Produit CABOMETYX®
2. Chan JA, *et al*. Phase 3 Trial of Cabozantinib to Treat Advanced Neuroendocrine Tumors. N Engl J Med 2025;392:653-65. [Etude retenue lors de l'évaluation du dossier d'AMM]

CMX-FR-000622 - 26/01/66607321/PM/009 - Janvier 2026

IPSEN PHARMA SAS - 70 rue Balard, 75015 Paris - Tél. : 01.58.33.50.00.
- Info. Médic. : 01.58.33.58.20. - information.medicale@ipsen.com.

Cet e-mail vous est adressé par VIDAL France et Ipsen en leur qualité de responsables conjoints du traitement. Les données personnelles traitées pour l'envoi de cette communication sont issues de la base de données des Professionnels de Santé de VIDAL France. Ipsen et VIDAL France ont conjointement déterminé les Professionnels de Santé destinataires de cet e-mail. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette opération, Ipsen n'est pas autorisé à accéder aux données (coordonnées, etc.) des Professionnels de Santé de la base VIDAL France.

IPSEN s'engage à respecter la charte de l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments et le référentiel de certification de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments en vigueur. Les collaborateurs d'IPSEN sont à votre disposition pour vous présenter les règles de déontologie formalisées par notre Entreprise et répondre à vos questions. Tout commentaire/réclamation concernant la visite d'information promotionnelle du laboratoire IPSEN PHARMA peuvent être adressé à l'adresse suivante : qualite.charte.vm@ipsen.com.

Si vous ne souhaitez plus que VIDAL France vous envoie des communications concernant les Actus Santé Labos, veuillez cliquer ici pour vous désinscrire.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de la part de VIDAL France, vous pouvez gérer vos préférences en cliquant sur ce lien.

Pour plus d'informations sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez consulter la Politique de protection des données personnelles de VIDAL France.